Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

SENTENÇA

Vistos e examinados estes autos sob nº 0802850-57.2024.8.12.0029 de **AÇÃO Procedimento Comum Cível** em que é **Autor:** Nadir Rodrigues Gomes da Silva e **Réu:** Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Nadir Rodrigues Gomes da Silva, qualificada nos autos, move a presente **Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa** em desfavor do **Município de Naviraí** e do **Estado de Mato Grosso do Sul,** também qualificados, dizendo, em resumo, que possui 70 anos de idade e apresenta quadro clínico de Diabetes Mellitus tipo 2. Diante disso, necessita dos medicamentos *Cloridrato de Metmorfina 1000mg* e *Glimepirid 2mg*, para tratamento de seu problema de saúde. Afirma que não conseguiu obter -los na rede pública de saúde, não lhe restando outra saída senão o ajuizamento da presente ação Com base em tais fatos sucintos, objetiva a condenação dos Requeridos para que lhe forneça os medicamentos supramencionados, pelo tempo que necessite para seu tratamento. Apresentou outros requerimentos. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 08/26.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico às fls. 28/35.

Tutela de urgência deferida (fls. 36/39).

Citados os Requeridos ofereceram contestação às fls. 51/57 e 62/70.

O Requerido Município de Naviraí em sua defesa alegou, em suma, que a Glimepirida não faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, de modo que não pode ser disponibilizada. Afirmou que eventual condenação ao fornecimento do medicamento comprometeria o orçamento público municipal. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Já o Requerido Estado de Mato Grosso do Sul na contestação ofertada, em síntese, discorreu pela necessidade preenchimento dos requisitos fixados pelo Tema 1.234/STF e Tema 6/STF para o fornecimento de medicamentos não disponibilizados pelo SUS. Subsidiariamente, postulou pelo direcionamento da obrigação ao Município.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que postulou pelo julgamento antecipado do feito (fls. 77/78).

Manifestação pelo Município de Naviraí às fls. 80.

Às fls. 83/106 foi juntado ofício referente ao Agravo de Instrumento n. 1418963-27.2024.8.12.0000.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802850-57.2024.8.12.0029 e código V1191R9h.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

Na fase de especificação de provas, os Requeridos disseram não possuir provas para produção (fls. 113 e 114).

É o relatório no essencial.

Decido.

Conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas, o que, aliás, não foi requerido por nenhuma das partes.

O ordenamento jurídico brasileiro tutela o direito à saúde, determinando o artigo 196 da Constituição Federal que:

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por sua vez, a Lei n.º 8.080, de 19/9/90, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estatui em seu artigo 2.º quec *"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"*. E, no artigo 7.º, que:

> "As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde − SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
> I − universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
> II − integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; IX − descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios".

Basta o dispositivo previsto no texto constitucional citado para se chegar à conclusão de que se deve garantir o direito de todos, <u>independentemente da condição financeira,</u> à saúde. As normas infraconstitucionais, que procuram dar efeito integrador ao texto constitucional, seriam até desnecessárias se existisse a consciência, por parte de todos os responsáveis pelas administrações dos entes federados, de que a Constituição Federal não é puramente analítica. A Constituição, com sua força normativa, constitui energia que deve influir na realidade. O dever da Administração de adquirir o necessário ao atendimento de pessoas doentes, imposto pela Constituição, não pode ser inviabilizado por entraves burocráticos e questiúnculas referentes à competência deste ou daquele órgão para distribuição. A distribuição de competências entre os entes federados é firmada para melhor servir aos cidadãos e não para aumentar seus sofrimentos e angústias, motivo pelo qual há solidariedade entre eles.

A edição da Lei nº 12.401/2011, em que pese sua importância e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802850-57.2024.8.12.0029 e código V1191R9h.

necessidade de respeito, não pode implicar em preterimento dos direitos do cidadão. A lei deve respeito à Constituição Federal e o Poder Judiciário é o garante das promessas do constituinte. Assim, como a Carta Magna traz a promessa de ampla proteção no campo da saúde, não pode o ente público se esquivar da sua obrigação, até porque estamos diante de tema que perpassa pela dignidade da pessoa humana. O Tribunal de Justiça do Estado, a respeito do tema já decidiu:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.401/2011 – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE PREVALECE SOBRE LEI, PORTARIA OU ATO NORMATIVO INFERIOR – DIREITO À SAÚDE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – MEDICAMENTO EXPERIMENTAL – SEM RELEVÂNCIA DESDE QUE INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 12.401/2011, posto que já é pacífico o entendimento de que a garantia ao acesso igualitário das pessoas saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal está acima de qualquer lei, portaria ou ato normativo inferior. Uma vez sopesados os interesses de ambas as partes, verifica-se que o princípio da integralidade que é fundamento do interesse do recorrente, não deve prevalecer sobre o princípio basilar da pretensão do recorrido, que é o da dignidade da pessoa humana. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Já é sedimentado o entendimento de que, se beneficiar o paciente, o médico pode utilizar um medicamento para finalidades diversas das indicadas, mesmo que em fase experimental. (TJMS, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, agravo nº 2012.015841-8, julgado em 17.07.2012).*

Desse modo, é patente a responsabilidade dos réus quanto ao atendimento das demandas relacionadas à saúde, o que, de resto, ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 793, que estabeleceu a seguinte tese:

> Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, **compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento** conforme as regras de repartição de competências **e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro**. (Grifei)

Portanto, os requeridos não podem se esquivar do cumprimento da obrigação, embora caiba ao juiz estabelecer, caso a caso, qual ente federativo deverá cumpri-la com prioridade.

Demonstrada a responsabilidade dos requeridos, verifico que, no caso, a parte autora demonstrou que possui uma demanda na área da saúde e que não conseguiu dos requeridos, administrativamente, os medicamentos de que necessita.

Pois bem, como relação ao medicamento *Cloridrato de Metmorfina 1000mg* não se verifica maiores problemas de compelir os Requeridos a fornecê-lo, uma vez que tal medicamento, de acordo com parecer do NAT, é normalmente distribuído

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802850-57.2024.8.12.0029 e código V1191R9h.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

pela Rede Pública de Saúde sob o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (fls. 34, item VII) e, portanto, havendo prescrição médica para seu uso, os demandados não podem fugir da sua obrigação constitucional.

Porém, a mesma conclusão não se aplica ao fármaco *Glimepirid 2mg*, pois ele não está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022) ou outro ato normativo do SUS (fls. 34, item VII).

Importa destacar, outrossim, que para medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser atendidas as exigências estabelecidas nos temas 106/STJ e 1.234/STF para que seja determinada a concessão deles, justamente por se tratar de medicamentos não incorporados.

Neste passo, cabe salientar que o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Resp 1.657.156 (Tema 106/STJ), já foram analisados por este Juízo por ocasião da decisão que deferiu a tutela provisória (fls. 36/39), cujos fundamentos mantiveram inalterados durante o transcorrer processual, de modo que os reitero *in tontum*, a fim de evitar repetições desnecessárias:

> "De acordo com tal recurso especial, para o fornecimento de remédios fora da lista do SUS, devem restar preenchidos os seguintes requisitos:
>
> ***(i)*** *Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
> ***(ii)*** *incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
> ***(iii)*** *existência de registro na ANVISA do medicamento.*
>
> Os dois últimos requisitos exigidos pelo REsp em comento são de fácil constatação, pois se denota que o remédio possui registro na ANVISA (fls. 33, item IV) e que o requerente é pessoa hipossuficiente, já que se encontra assistido pela Defensoria Pública e declara sua condição de hipossuficiência às fls. 09.
>
> Quanto à imprescindibilidade do fármaco, o laudo médico juntado às fls. 11/17 a comprova, uma vez que atesta que a paciente já utilizou outros medicamentos fornecidos pelo SUS para o mesmo fim, entretanto não obteve resultado efetivo:

7. Existem tratamentos oferecidos pelo SUS para a(s) doença(s) citada(s) com a mesma eficácia do tratamento indicado? Se afirmativa a resposta, qual(is)?
Sim, Glimepirida, Porém não efetivo.

8. A(s) alternativa(s) terapêutica(s) oferecida(s) pelo SUS para a(s) doença(s) já foi(ram) utilizada(s)?
( ) Sim **( ) Não**
8.1. Em caso afirmativo especifique qual(is):
Glimepirida Porém não efetivas.

8.2. Por quanto tempo foi(ram) utilizada(s):
(X) + de 01 ano **( ) + de 06 meses** **( ) – de 06 meses** **( ) Prejudicado**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802850-57.2024.8.12.0029 e código V1191R9h.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

9- CID-10* E|1|1|

10- Diagnóstico Diabetes Mellitus Tipo 2.

11- Anamnese* Paciente Diabética tipo 2, apresenta melhora dos níveis glicêmicos com a medicação em questão, não tendo se adaptado com outras medicações oferecidas pelo SUS. em tratam. anteriores.

Portanto, como justificado pela médica que atende a Requerente, ambos os medicamentos pleiteados são necessários e não podem ser substituídos."

Outrossim, a respeito das exigências estabelecidas no Tema 1.234 a respeito do fornecimento dos medicamentos não incorporados às políticas públicas, o STF firmou as seguintes teses:

> *IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS*
> *4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente* ***analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa****, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. [...]*
> *4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado,* ***é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto*** *terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.* – destaquei

Desse modo, tornou-se imprescindível o exame judicial do ato administrativo (c)omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa. Além disso, é do autor o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto incorporado pelo SUS.

Em relação à negativa de fornecimento na via administrativa, verifico que a parte autora buscou administrativamente o fármaco junto aos entes públicos, todavia, foi informada pelo Município de Naviraí que *o medicamento não se encontra nas listas de medicamentos CAFE e RENAME, ou seja, não é fornecido pelo SUS, sendo assim, não há previsão orçamentária para aquisição no momento* (fls. 23).

Em relação ao exame dos atos normativos da CONITEC, resta prejudicada tal análise, uma vez que, no parecer técnico, não constou nenhuma informação acerca da referida avaliação em relação à *Glimepirid 2mg*. De qualquer forma a ausência de avaliação técnica da CONITEC sobre o fármaco pleiteado caracteriza omissão administrativa relevante que legitima a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802850-57.2024.8.12.0029 e código V1191R9h.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

> MEDICAMENTO – SITAGLIPTINA 100 MG – NÃO INCORPORADO AO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ E TEMA 1234 DO STF – TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] Analisa-se se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 106 e pelo STF no Tema 1234, além da legalidade da decisão de primeira instância que deferiu a tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão judicial do medicamento Sitagliptina 100 mg atende aos critérios estabelecidos no REsp 1.657.156 (Tema 106 do STJ): (i) laudo médico fundamentado quanto à imprescindibilidade do fármaco e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; (ii) hipossuficiência econômica comprovada; (iii) registro do medicamento na ANVISA. **A situação fática revela omissão administrativa quanto à análise de incorporação do medicamento pela CONITEC, aberta em 2015 sem parecer técnico até a presente data, configurando violação aos preceitos do SUS e à proteção à saúde.** Ensaios clínicos randomizados atestam a eficácia do medicamento pleiteado, reforçando sua indicação médica específica para o caso concreto, com respaldo em evidência científica. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que atendidos cumulativamente os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ e Tema 1234 do STF, especialmente quanto à imprescindibilidade clínica fundamentada, hipossuficiência econômica e registro na ANVISA. **A ausência de avaliação técnica da CONITEC sobre o fármaco pleiteado caracteriza omissão administrativa relevante, legitimando a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.** [...] (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1404100-32.2025.8.12.0000, Maracaju, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j: 18/05/2025, p: 20/05/2025)

Quanto à comprovação, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, da segurança e eficácia do fármaco, bem como da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, entendo que os elementos constantes nos autos são suficientes para comprovar a imprescindibilidade do tratamento.

Além do laudo médico de fls. 11/17 que, como já mencionado, atestou que a paciente já utilizou outros medicamentos, entretanto não obteve resultado, verifico, também, que o Parecer do NAT trouxe informações e evidências científicas sobre a *Glimepirida*, dentre as quais destaco os seguintes pontos (fls. 32, item III):

> *"O **Betes** (nome comercial) **Glimepirida** (princípio ativo) é a sulfonilureia mais recentemente aprovada para uso terapêutico. É administrada uma vez ao dia, em doses variando de 1 a 8 mg. Sua absorção é rápida, atingindo efeito hipoglicemiante máximo em 2 a 3 horas, mas ainda evidente após 24 horas.*
> *[...]*
> *Atualmente, há no mercado disponibilidade variada desses agentes, os quais atuam através de diferentes mecanismos: aumento da secreção de insulina, redução da produção hepática de glicose, retardo na absorção de carboidratos e/ou aumento da sensibilidade à insulina.*
> *[...]*
> *As provas de melhor eficácia ou menor incidência de hipoglicemia de sulfonilureias*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802850-57.2024.8.12.0029 e código V1191R9h.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

mais novas são de baixa qualidade, mas há demonstrações de moderada qualidade de que glimepirida e gliclazida apresentem efetividade semelhante na redução da hemoglobina glicosilada."

Portanto, restou comprovada, consoante exigências estabelecidas nos temas citados, a necessidade de realização de tratamento com estes medicamentos específicos, de maneira que a procedência do pedido é a medida que se impõe.

Ante o exposto, confirmando neste momento a antecipação dos efeitos da tutela, **JULGO PROCEDENTE** o pedido que **Nadir Rodrigues Gomes da Silva** fez em desfavor do **Município de Naviraí** e do **Estado de Mato Grosso do Sul**, qualificados, para o fim de determinar aos réus que forneçam por meio de seus órgãos executores competentes, à parte autora, os medicamentos ***Cloridrato de Metmorfina 1000mg* e Glimepirid 2mg**, pelo nome comercial ou princípio ativo, na quantidade necessária para seu tratamento e mediante a apresentação de receituário médico, no prazo de 20(vinte) dias, a contar da intimação dos Réus do teor desta decisão.

Deixo de fixar multa pelo descumprimento da obrigação, pois, segundo consta dos autos, os medicamentos vêm sendo disponibilizados (fls. 81 destes autos e fls. 56 dos autos em apenso, n. 0803891-59.2024).

Quanto ao medicamento *Cloridrato de Metmorfina 1000mg*, DIRECIONO o cumprimento da obrigação ao Município de Naviraí, pois, segundo o NAT, o referido ente público é o responsável pelo fornecimento (fls. 34, item VIII), o que faço em vista das premissas estabelecidas pelo STF no Tema 793. Já em relação ao fármaco *Glimepirid 2mg*, por se tratar de fármaco não padronizado no SUS, DEIXO DE DIRECIONAR o cumprimento da obrigação a um dos réus. De qualquer forma, a obrigação permanece integralmente solidária frente à parte autora.

Sem custas, *ex vi legis*.

Em vista do que restou decidido no Tema n. 1.002 do STF[1], condeno os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que fixo em R$800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, já considerado o grau de zelo do profissional, a importância e a natureza da causa, o tempo e o lugar da prestação do serviço. Ainda, com fulcro no art. 87, § 1º, do CPC, determino a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais em 50% entre os litisconsortes passivos.

Declaro **extinto** o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença sujeita a reexame, pois não é certo o valor da

[1] O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou tese vinculante no sentido de que "é devido o pagamento de *honorários* sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra."

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802850-57.2024.8.12.0029 e código V1191R9h.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

condenação, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC e Súmula 490 do STJ. Assim, decorrido o prazo recursal, mesmo sem oposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E. TJMS para reexame.

Havendo o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades.

P.R.I.C.

Naviraí/MS, datado e assinado digitalmente.

Eduardo Magrinelli Júnior
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 26/06/2025 às 13:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802850-57.2024.8.12.0029 e código V1191R9h.